

Cycle de préparation au concours de résidanat

Session de Décembre 2025

Objectif n°38 :

***Hypertension artérielle : Epidémiologie,
Physiopathologie, Etiopathogénie, Diagnostic,
Complications, Traitement.***

Tests d'auto-évaluation

Dr Mejd Ben Messaoud

QCM :

1) La pression artérielle moyenne est :

- A. La pression de perfusion des organes
- B. Un paramètre homéostatique
- C. Proportionnelle à la résistance à l'écoulement de sang dans le système artériel
- D. Inversement proportionnelle au débit cardiaque
- E. Proportionnelle à la fréquence cardiaque
- F. Essentiellement dépendante de la pression artérielle diastolique
- G. Plus proche de la pression diastolique
- H. Proportionnelle à la diurèse
- I. Augmentée en cas de présence d'une artériosclérose

ABCEFGI

2) Une diminution brutale de la pression artérielle moyenne entraîne :

- A. Une diminution de la fréquence de décharge dans le nerf du sinus carotidien
- B. Une augmentation des influx parasympathiques vers le cœur
- C. Une diminution de la fréquence cardiaque
- D. Une diminution de la contractilité cardiaque
- E. Une levée de l'inhibition du centre vasomoteur

AE

3) Après une élévation rapide de la pression artérielle moyenne :

- A. L'activité sympathique augmente
- B. La fréquence des influx nerveux provenant des barorécepteurs augmente
- C. L'activité du centre vagal augmente
- D. Les récepteurs α -adrénergiques sont moins stimulés
- E. L'activité du noyau du tractus solitaire est inhibée

BCD

4) Dans la régulation de la pression artérielle moyenne :

- A. Le baroréflexe intervient dans la régulation au long cours
- B. Les afférences sont de type sympathique ou parasympathique
- C. Le centre vasomoteur est freiné en permanence par le noyau du tractus solitaire à l'état de base
- D. L'activation du parasympathique est responsable d'une vasodilatation
- E. Les barorécepteurs sont stimulés par une baisse de la pression artérielle moyenne

C

5) La stimulation des barorécepteurs entraine :

- A. La sécrétion d'ADH
- B. La stimulation du noyau du tractus solitaire
- C. La levée de l'inhibition du centre vasomoteur
- D. Une activation vagale
- E. Une augmentation de la fréquence de décharge des voies afférentes

BDE

6) Le système sympathique :

- A. Assure une régulation à long terme de la pression artérielle
- B. Agit essentiellement sur les récepteurs alpha-adrénergiques au niveau du cœur
- C. Agit par l'intermédiaire des barorécepteurs aortiques et sinocarotidiens
- D. Assure ses fonctions à travers le nerf vague
- E. Agit uniquement sur le cœur au cours de la régulation de la pression artérielle
- F. A une action inotrope et chronotrope positive
- G. Donne une bronchodilatation à travers les récepteurs bêta2

CFG

7) Le système parasympathique :

- A. Est stimulé à l'état de base par le noyau du tractus solitaire
- B. Intervient dans la régulation de la pression artérielle par ses effets cardiaques et vasculaires
- C. A un effet inotrope positif
- D. Allonge le temps de conduction atrio-ventriculaire
- E. A un effet cardiomodérateur
- F. Assure l'innervation du tissu nodal cardiaque par des récepteurs muscariniques

ADEF

8) L'activation des barorécepteurs :

- A. Est secondaire à une hypovolémie
- B. Inhibe le noyau du vague
- C. Inhibe le centre vasomoteur

- D. Augmente les résistances périphériques totales
- E. Inhibe la sécrétion de rénine

CE

9) Les résistances périphériques totales augmentent en cas de:

- A. Augmentation de la viscosité sanguine
- B. Augmentation du diamètre du vaisseau
- C. Augmentation de la longueur du vaisseau
- D. Libération de rénine
- E. Orthostatisme
- F. Hémorragie
- G. Paroi riche en fibres musculaires lisses
- H. Sécrétion importantes d'hormones thyroïdiennes
- I. Exercice physique prolongé de moyenne intensité

ACDEFG

10) La vasomotricité :

- A. Correspond à un changement du calibre vasculaire
- B. Est un phénomène actif
- C. Est une propriété des veines
- D. Est régulée principalement par le parasympathique
- E. Est à l'origine des résistances périphériques totales

A B E

11) L'aldostérone :

- A. Augmente la réabsorption rénale de K^+ au niveau du tube distal
- B. Augmente la réabsorption de Na^+ et l'excrétion de K^+ au niveau de la cellule principale
- C. Augmente l'activité de la pompe Na^+/K^+ ATPase basolatérale
- D. Stimule la sécrétion de rénine
- E. Active la pompe H^+ ATPase de la cellule intercalaire A

B C E

12)Le FAN:

- A. Augmente le débit de filtration glomérulaire
- B. Augmente la fraction de filtration glomérulaire
- C. Augmente le coefficient d'ultrafiltration
- D. Stimule la sécrétion d'ADH
- E. Augmente la réabsorption de Na⁺
- F. Donne une vasodilatation périphérique

A B C F

13)La rénine :

- A. A un effet vasoconstricteur direct
- B. Transforme l'angiotensinogène en angiotensine I
- C. Est sécrétée par le foie
- D. Sa libération est proportionnelle au contenu sodique
- E. Est une hormone synthétisée au niveau du rein
- F. Est libérée en réponse à une augmentation de la pression de perfusion rénale
- G. Est stimulée par l'orthostatisme
- H. Est stimulée par le sympathique

B G H

14)L'angiotensine II:

- A. Stimule la sécrétion de la rénine
- B. Stimule la sécrétion d'ADH
- C. Augmente la réabsorption du sodium au niveau du tube proximal
- D. Stimule la sécrétion de noradrénaline
- E. Donne une vasoconstriction de l'artériole afférente et efférente rénales
- F. Stimule la sensation de la soif

G. A un effet inotrope négatif sur le cœur

B C D E F

15) La vasoconstriction de l'artériole efférente est secondaire à l'action directe de :

- A. L'aldostérone
- B. L'angiotensine II
- C. Les catécholamines
- D. Le FAN
- E. La rénine

B C D

16) La régulation hormonale de la volémie fait intervenir en premier :

- A. L'aldostérone
- B. Les catécholamines
- C. L'angiotensine II
- D. L'ADH
- E. L'ACTH

B

17) L'activation du système rénine angiotensine aldostérone est à l'origine de :

- A. Une rétention hydro-sodée
- B. Une vasoconstriction
- C. Une fibrose myocardique
- D. Une stimulation de la sécrétion d'ADH (vasopressine)
- E. Une diminution de l'excrétion urinaire de potassium
- F. Une diminution de l'excrétion urinaire de H⁺.
- G. Une stimulation du parasympathique

A B C D

18) Une vasoconstriction locale est assurée par :

- A. L'endothéline 1
- B. Le monoxyde d'azote
- C. Le thromboxane A2
- D. L'acidose
- E. Les bradykinines

A C

19) L'HVG secondaire à l'HTA :

- A. Est concentrique
- B. Est asymétrique
- C. Est secondaire à l'augmentation de la post-charge du VG
- D. Diminue les réserves coronaires en oxygène
- E. Est à l'origine de trouble de la relaxation du VG
- F. Est confirmée par l'échographie cardiaque
- G. Augmente le risque cardiovasculaire global

A C D E F G

20) Les examens suivants doivent être demandés de façon systématique dans le cadre du bilan initial d'HTA ?

- A. Acide urique
- B. Bilan lipidique
- C. NFS
- D. ECG
- E. Echographie cardiaque
- F. Fond d'œil

- G. Radiographie de thorax
- H. TP

A B C D

21) Quels sont les arguments qui orientent vers une HTA secondaire ?

- A. Des antécédents familiaux d'HTA
- B. Une HTA modérée
- C. L'origine subsaharienne
- D. Une insuffisance rénale sous IEC
- E. La découverte de l'HTA à l'âge de 60 ans
- F. Un souffle lombaire
- G. Une hypokaliémie
- H. Une élévation prédominante de la PAD
- I. Consommation de pilule ou corticostéroïdes
- J. Signes cliniques d'hyperthyroïdie

D F G I J

22) Dans l'hyper-aldostéronisme primaire, on trouve :

- A. Une diminution de la réabsorption de Na^+
- B. Une augmentation de l'excrétion de K^+
- C. Une activité rénine plasmatique élevée
- D. Une aldostéronémie élevée
- E. Une hyperkaliémie
- F. Une alcalose métabolique

B D F

23) Une micro-albuminurie:

- A. Est spécifique d'HTA sévère
- B. Est un marqueur précoce d'atteinte rénale
- C. Peut diminuer ou disparaître sous traitement d'HTA
- D. Contre indique le traitement par les IEC
- E. Aggrave le risque cardiovasculaire global

B C E

24) Une sténose des artères rénales est suspectée en cas de:

- A. Une HTA résistante
- B. Une aggravation de la fonction rénale sous inhibiteurs calciques
- C. Un souffle lombaire
- D. Des antécédents de traumatisme lombaire
- E. Une HTA systolique isolée
- F. Une leucocyturie

A C D

25) L'objectif tensionnel à atteindre chez un hypertendu diabétique de 60 ans est :

- A. 140/90
- B. 130/80
- C. 130/85
- D. 140/8
- E. 120/70

B

26) L'objectif tensionnel à atteindre chez un hypertendu de 86 ans est :

- A. 140/90
- B. 130/80
- C. 130/85
- D. 140/80
- E. 120/70

D

27) Concernant la sténose des artères rénales :

- A. L'activité rénine plasmatique est basse
- B. L'aldostéronémie est élevée
- C. Elle constitue la principale cause d'hyperaldostéronisme primaire
- D. Elle est suspectée en cas d'hypokaliémie
- E. Son traitement de référence est chirurgical
- F. La dysplasie fibro-musculaire en constitue la principale cause
- G. L'artériographie des artères rénales est indiquée en première intention pour la confirmation du diagnostic

B D

28) Une HTA peut être secondaire:

- A. A la Glycerrhizine (réglisse)
- B. Aux oestro-progestatifs
- C. A certains psychotropes
- D. Aux vasoconstricteurs nasaux
- E. Aux IPP
- F. Aux statines
- G. Aux hypnotiques

A B C D

29) Une HTA résistante :

- A. Est définie par une HTA avec un retentissement viscéral
- B. Est définie par une PAD > 130 mmHg avec un FO stade III
- C. Est définie par des chiffres tensionnels élevés malgré une trithérapie anti-hypertensive
- D. Est rare
- E. Doit faire chercher un défaut d'observance thérapeutique ou un effet blouse blanche
- F. Est expliquée souvent par l'épuisement de l'effet du traitement anti-hypertenseur
- G. Doit faire évoquer une HTA secondaire
- H. Représente l'indication d'un traitement par spironolactone, une fois confirmée.
- I. Doit être confirmée par une MAPA ou une automesure à domicile

E G H I

30) Les signes échographiques caractéristiques du retentissement cardiaque d'HTA sont:

- A. Une dilatation du VG
- B. Une dilatation de l'aorte ascendante
- C. Une HVG concentrique
- D. Une altération de la fonction systolique du VG
- E. Des troubles de la relaxation du VG
- F. Des anomalies de la cinétique segmentaire du VG
- G. Une HTAP

C E

31) En faveur d'un hypercorticisme :

- A. Une cortisolémie de 24 H élevée
- B. La disparition du rythme nyctéméral de la cortisolémie
- C. Un cortisol libre urinaire bas
- D. Une obésité facio-tronculaire
- E. Un traitement au long cours par des corticoïdes

A B D E

32) Quels sont les médicaments autorisés en cas d'HTA gravidique :

- A. Les IEC
- B. Les bêtabloquants
- C. Les inhibiteurs calciques
- D. Les ARA II
- E. Les anti-hypertenseurs centraux
- F. Les diurétiques

B C E

33) Les IEC ont les effets suivants:

- A. Une bradycardie
- B. Une diminution des RPT
- C. Une levée de la vasoconstriction de l'artériole efférente
- D. Une baisse du débit cardiaque
- E. Une diminution de la sécrétion de rénine
- F. Une impuissance sexuelle

B C

34) Les contre-indications des IEC sont:

- A. Une insuffisance rénale aiguë sévère
- B. Une insuffisance rénale chronique stable
- C. Une insuffisance cardiaque
- D. Une insuffisance coronaire
- E. Une sténose bilatérale des artères rénales
- F. Une hyperkaliémie majeure
- G. Un diabète
- H. Une albuminurie

A E F

35) Les IEC ont comme effets secondaires :

- A. Une insuffisance rénale aiguë
- B. Un BAV
- C. Un angioedème
- D. Une hyperkaliémie
- E. Une toux sèche
- F. Des bouffées de chaleur
- G. Une dysgueusie
- H. Un œdème malléolaire

A C D E G

36) Les diurétiques de l'anse :

- A. Agissent au niveau de la branche descendante de Henlé
- B. Augmentent la diurèse
- C. Inhibent la réabsorption du sodium
- D. Diminuent la kaliurèse
- E. Inhibent l'anhydrase carbonique

- F. Figurent parmi les médicaments de première intention dans le traitement d'HTA
- G. Peuvent donner une insuffisance rénale

B C G

37) Les bêtabloquants :

- A. Ont un effet inotrope négatif
- B. Inhibent la sécrétion de la rénine
- C. Ralentissent la conduction atrio-ventriculaire
- D. Peuvent aggraver une BPCO
- E. Sont contre indiqués en cas de diabète
- F. Agissent principalement sur les récepteurs B1 rénaux
- G. Peuvent masquer une hypoglycémie

A B C D G

38) Les indications préférentielles des bêtabloquants dans le traitement d'HTA sont:

- A. Une hyperthyroïdie
- B. Un OAP
- C. Une dissection de l'aorte
- D. Un syndrome coronarien aigu
- E. Une insuffisance cardiaque chronique
- F. Une grossesse
- G. Un phénomène de Reynaud
- H. Un asthme ou une BPCO sévères

A C D E F

39) Les inhibiteurs calciques type dihydropyridine :

- A. Ont un tropisme cardiaque
- B. Inhibent la contraction des cellules musculaires lisses vasculaires
- C. Donnent une bradycardie
- D. Peuvent donner des œdèmes des membres inférieurs
- E. Diminuent les résistances périphériques totales
- F. Sont contre indiqués en cas de phénomène de Reynaud
- G. Sont indiqués dans les troubles de rythme cardiaque
- H. Peuvent donner une tachycardie réflexe

B D E H

40) Les inhibiteurs calciques type non dihydropyridine :

- A. Ont un tropisme cardiaque uniquement
- B. Accélèrent la fréquence cardiaque
- C. Sont indiqués dans les angors spastiques
- D. Sont contre indiqués en cas de trouble conducteur majeur
- E. Sont indiqués dans les troubles de rythme cardiaque

C D E

41) Les atteintes d'organe cible liées à l'HTA sont:

- A. Une HVG
- B. Une insuffisance cardiaque
- C. Un IPS > 1.1
- D. Une micro-albuminurie

- E. Une épaisseur intima-média > 0.9 mm
- F. Une VOP > 12 m/sec
- G. Un AIT

A D E F

42) En cas d'urgence hypertensive, une baisse rapide et importante de la pression artérielle systolique jusqu'à 120 mmHg est exigée dans une situation, laquelle :

- A. IDM
- B. OAP
- C. AVC ischémique
- D. AVC hémorragique
- E. Dissection de l'aorte
- F. Œdème papillaire
- G. Crise d'éclampsie

E

43) Les facteurs de risque cardiovasculaires majeurs sont:

- A. L'HTA
- B. Le tabac
- C. Le diabète de type 2
- D. La sédentarité
- E. L'hypertriglycémie
- F. L'hypercholestérolémie
- G. L'obésité

A B C F

44) Un patient âgé de 65 ans, diabétique et coronarien, consulte pour des chiffres tensionnels élevés. La pression artérielle est mesurée à 190/110 mmHg à 3 reprises. Quelle serait votre conduite ?

- A. Conseiller les règles hygiéno-diététiques puis revoir le patient dans 2 semaines
- B. Hospitaliser le patient en urgence
- C. Indiquer une MAPA pour confirmer l'HTA
- D. Prescrire d'emblée une bithérapie antihypertensive
- E. Demander des examens biologiques puis revoir le patient dans une semaine

D

45) Les complications suivantes sont secondaires à l'HTA ?

- A. Un AVC
- B. Une embolie pulmonaire
- C. Une lithiase rénale
- D. Une fibrillation auriculaire
- E. Une insuffisance rénale
- F. Une altération de la fonction diastolique cardiaque
- G. Une insuffisance coronaire

A D E F G

46) Une urgence hypertensive :

- A. Est définie par une crise hypertensive avec une souffrance viscérale aiguë
- B. Est définie par un objectif tensionnel non atteint malgré une trithérapie anti-hypertensive
- C. Nécessite le renforcement du traitement antihypertenseur en ambulatoire
- D. Indique une hospitalisation en urgence

E. Nécessite la réalisation systématique d'un scanner cérébral en urgence

AD

47) Les antihypertenseurs suivants peuvent être prescrits au cours de la grossesse :

- A. L'acebutolol
- B. Le périndopril
- C. La nifédipine
- D. Le méthyl dopa
- E. Le valsartan

ACD

48) La prescription de l'amlodipine dans le traitement d'HTA peut être associée aux effets secondaires suivants :

- A. Une insuffisance rénale aiguë
- B. Une toux sèche
- C. Une bradycardie
- D. Des œdèmes malléolaires
- E. Des bouffées de chaleur

DE

49) L'hypertrophie ventriculaire gauche secondaire à l'HTA :

- A. Est concentrique
- B. Est confirmée par l'électrocardiogramme
- C. Est secondaire à l'augmentation de la post-charge du ventricule gauche
- D. Définit une atteinte d'organe cible cardiaque
- E. Est responsable d'une diminution des besoins coronaires en oxygène

ACD

50) Les signes électriques en faveur d'une HTA sont :

- A. Un BAV de deuxième degré
- B. Un indice de Sokolow à 40 mm

- C. Un axe droit du cœur
- D. Un sous décalage de ST avec onde T négative en V5V6
- E. Une hypertrophie ventriculaire droite

BD

51) Les complications vasculaires d'une HTA sont :

- A) Un anévrisme de l'aorte abdominale
- B) Une artériopathie des membres inférieurs
- C) Une dissection de l'aorte
- D) Une rigidité artérielle traduite par une diminution de la vitesse de l'onde de pouls carotido-fémoral
- E) Une vascularite

ABC

52) Les examens complémentaires suivants sont demandés pour détecter une atteinte d'organe cible :

- A) HBA1C en cas de glycémie élevée
- B) Scanner cérébral en cas d'une hémiplégie
- C) ETT en cas d'HVG électrique
- D) Epreuve d'effort ou scintigraphie myocardique en cas d'angor
- E) FO en cas de flou visuel
- F) PU de 24H si bandelette urinaire positive

CEF

53) Les diurétiques thiazidiques :

- A) Agissent sur la branche ascendante de Henlé
- B) Sont indiqués préférentiellement chez le sujet âgé ou de race noire
- C) Donnent une hyperuricémie
- D) Donnent une hypercalcémie
- E) Donnent une acidose métabolique

BCD

54) Le risque d'hyperkaliémie est majoré par l'association de :

- A) Bétabloquant + diurétique
- B) Inhibiteur calcique + diurétique thiazidique
- C) IEC + inhibiteur calcique
- D) ARA II + antialdostérone
- E) Bétabloquant + antihypertenseur central

D

55) Une HTA maligne comporte les signes suivants:

- A) Une PAD ≥ 100 mmHg
- B) Un FO stade I ou II
- C) Une encéphalopathie hypertensive
- D) Une insuffisance rénale aiguë sévère
- E) Une crise d'OAP

CDE

56) Vous avez décidé de prescrire une association de 2 antihypertenseurs chez un patient diabétique hypertendu. Parmi ces associations, lesquelles peuvent être indiquées en première intention?

- A) Un inhibiteur de l'enzyme de conversion + un diurétique thiazidique
- B) Un inhibiteur calcique + un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II
- C) Un bêtabloquant + un inhibiteur calcique
- D) Un inhibiteur de l'enzyme de conversion + un inhibiteur calcique
- E) Un antihypertenseur central + un inhibiteur calcique

ABD

57) Les arguments suivants sont en faveur d'un phéochromocytome :

- A) Des poussées hypertensives sévères
- B) L'association de céphalées, sueurs et palpitations
- C) Des épisodes fréquents d'hypoglycémie
- D) Une Polyglobulie
- E) Une hyperparathyroïdie
- F) HTA systolique isolée
- G) Une anxiété
- H) Une hypokaliémie

ABDEG

58) Au cours de l'HTA Rénio-vasculaire, l'aortographie rénale est un examen:

- A) Indiqué d'une façon systématique en cas de suspicion de sténose de l'artère rénale
- B) Qui confirme avec certitude l'origine rénio-vasculaire de l'HTA
- C) Indiqué en cas de geste interventionnel prévu
- D) Invasif
- E) Qui peut être remplacé par le doppler des artères rénales

BCD

59) Parmi les propositions suivantes, quelles sont les deux causes les plus fréquentes d'HTA secondaire ?

- A) SAOS
- B) Hyper aldostérionisme primaire
- C) Néphropathies glomérulaires
- D) Sténose de l'artère rénale
- E) Phéochromocytome

AD

60) Un risque très élevé selon GLOBORISK est défini par :

- A) Un diabète type 2
- B) Un diabète type 2 avec atteinte d'organe cible
- C) Une maladie coronaire
- D) Un score $> 20\%$
- E) IRC modérée

BC

61) Les paramètres inclus dans le calcul du GLOBORISK sont :

- A) L'âge
- B) Le sexe
- C) Le tabac
- D) Le diabète
- E) Le poids

ABCD

62) Une monothérapie anti-hypertensive est indiquée en cas de :

- A) HTA grade 1 avec risque cardiovasculaire élevé
- B) HTA grade 1 avec faible risque cardiovasculaire
- C) Une PA élevée avec GLOBORISK à 10%
- D) Une PA élevée avec GLOBORISK à 30%
- E) Un sujet âgé de 87 ans avec HTA confirmée

DE

63) En cas d'HTA grade 1 confirmée, la conduite à tenir serait :

- A) Des règles hygiéno-diététiques seules
- B) Des règles hygiéno-diététiques avec une monothérapie à faible dose
- C) Des règles hygiéno-diététiques avec une bithérapie à faible dose
- D) Des règles hygiéno-diététiques avec une bithérapie à pleine dose
- E) Des règles hygiéno-diététiques avec une monothérapie à pleine dose

C

64) Le GLOBORISK d'un patient âgé de 65 ans, hypertendu, diabétique type 2 avec une HVG est :

- A) > 30%
- B) > 25%
- C) > 20%
- D) > 15%
- E) > 10%

A

CAS CLINIQUES :

Cas clinique n°1:

Un patient âgé de 30 ans, tabagique, consulte aux urgences pour céphalées et bourdonnement d'oreilles.

L'examen somatique est normal en dehors d'une pression artérielle à 185/100 mmHg contrôlée à trois reprises.

- 1) Parmi ces examens complémentaires, lesquels doivent être demandés systématiquement dans le bilan initial d'HTA chez ce patient?
- A) Un ECG
 - B) Une radiographie de thorax
 - C) Un fond d'œil
 - D) Une uricémie
 - E) Une calcémie

ACD

Le patient a été mis sous Perindopril 10 mg 1cp/j et amlodipine 5 mg 1 cp/j avec des mesures hygiéno-diététiques d'HTA et a été adressé à un cardiologue pour complément de suivi.

- 2) Parmi les règles hygiéno-diététiques d'HTA, vous retenez :
- A) Un régime sans sel strict
 - B) Une réduction du poids pour un BMI < 25 Kg/m²
 - C) Un régime alimentaire riche en protéines animales
 - D) Un régime pauvre en apports hydriques
 - E) Une limitation de l'activité physique quotidienne

B

Deux semaines après, le patient consulte aux urgences pour orthopnée.

L'examen met en évidence une pression artérielle à 220/120 mm Hg, une polypnée et des râles crépitants diffus.

La biologie montre une aggravation sévère de la fonction rénale (qui était normale) avec une hypokaliémie.

La radiographie de thorax montre un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral.

- 3) A ce stade de l'examen, quelle serait l'étiologie la plus probable d'HTA chez ce patient ?
- A) Un phéochromocytome
 - B) Une HTA essentielle
 - C) Une sténose bilatérale des artères rénales
 - D) Un hypercorticisme
 - E) Une coarctation de l'aorte

C

- 4) Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez-vous pour confirmer votre diagnostic ?
- A) Angioscanner aortique
 - B) Angioscanner des artères rénales
 - C) Echographie doppler des artères rénales
 - D) Scanner des surrénales
 - E) Une artériographie rénale

C

Cas clinique n°2 :

Patiente âgée de 42 ans, suivie pour hypertension artérielle depuis 5 ans sous Lopril 25 mg 1cp/2/jour, consulte aux urgences pour une dyspnée brutale. L'examen physique trouve : Patient orthopnéique, polypnéique. La SaO₂ à l'air ambiant=86%. Tension artérielle= 230/120 mmHg. Fréquence cardiaque= 120bpm. Des râles crépitants aux deux champs pulmonaires.

1) Quel(s) est (sont) le (les) diagnostic(s) à évoquer chez cette patiente ?

- A) Crise hypertensive simple
- B) Crise hypertensive sévère
- C) Urgence hypertensive
- D) Hypertension maligne
- E) Crise d'asthme

C

2) Quel(s) traitement(s) urgent(s) à instaurer chez cette patiente ?

- A) Dérivés nitrés par voie IV
- B) Diurétiques par voie IV
- C) Béta-bloquants par voie orale
- D) Oxygénothérapie
- E) Alpha bloquants par voie orale

ABD

3) Quel(s) est (sont) le (les)élément(s) à rechercher par l'interrogatoire chez cette patiente :

- A) Prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens
- B) Arrêt du son traitement anti-hypertenseur
- C) Prise de contraceptifs oraux
- D) Prise de bêta-bloquants
- E) Prise des antidépresseurs

ABCE

Cas clinique n°3:

Madame MR présente une HTA mal-équilibrée à 220/100 aux 2 bras, sous Acebutolol et methylDopa. L'interrogatoire révèle une consommation de réglisse depuis plus de 10 ans (200mg/j) arrêtée depuis 3 mois. L'examen clinique est normal.

Biologie: L'ionogramme sanguin: Na 142, K3.3, Créatinine: 75 μ mol/l, Ionogramme urinaire: Na 90 mEq/l, K 30 mEq/l pour une diurèse à 1.5l/24h, sans protéinurie.

L'activité rénine plasmatique est à 0.2ng/ml/h (0.2-0.7).

Aldostéronémie 920pmol/l (30-220)

Un test au Captopril: rénine plasmatique est à 0.02ng/ml/h et Aldostéronémie 1000 pmol/l

Dosage des VMA et des dérivés méthoxylés sont normaux.

1) Le tableau clinique et biologique de cette HTA évoque :

- A) Une HTA rénovasculaire
- B) Une HTA essentielle
- C) Une HTA d'origine iatrogène

- D) Une HTA d'origine endocrinienne
- E) Aucune de ces étiologies

D

2) L'ensemble du tableau évoque :

- A) Une intoxication à la réglisse
- B) Un hyperaldostéronisme secondaire
- C) Un hyperaldostéronisme primaire
- D) une sténose de l'artère rénale
- E) Un phéochromocytome

C

1) Dans un but diagnostic, la prescription peut comporter:

- A) L'artériographie sélective des artères rénales
- B) Le scanner rénal et surrénal
- C) L'échographie des surrénales
- D) Les prélèvements étagés de rénine
- E) Scintigraphie surrénale à l'iodocholestérol

BCE

Cas clinique n°4 :

Un patient âgé de 66 ans, diabétique et coronarien, consulte pour une HTA confirmée par MAPA.

1) Le diagnostic d'HTA est retenu si la pression artérielle moyenne de 24 heures à la MAPA est supérieure à :

- A) 140/90 mmHg
- B) 135/85 mmHg
- C) 130/80 mmHg
- D) 125/75 mmHg
- E) 120/70 mmHg

C

2) L'analyse de la MAPA a montré un profil Non dipper. Ce profil correspond à :

- A) Une baisse de la pression artérielle en période nocturne entre 10 et 20%.
- B) Une baisse de la pression artérielle en période nocturne > 20%.

- C) Une baisse de la pression artérielle en période nocturne entre 0 et 10%.
- D) Une augmentation de la pression artérielle en période nocturne > 10%
- E) Une augmentation de la pression artérielle en période nocturne > 20%.

C

3) Le GLOBORISK de ce patient est supérieur à :

- A) 10%
- B) 15%
- C) 20%
- D) 25%
- E) 30%

E

4) L'attitude thérapeutique chez ce patient serait :

- A) Une bithérapie immédiate à faible dose
- B) Une bithérapie immédiate à pleine dose
- C) Une monothérapie immédiate à faible dose
- D) Une monothérapie immédiate à pleine dose
- E) Des règles hygiéno-diététiques seules

A